

CAPÍTULO 14.30

Espondiloartritis Anquilosante

PERFIL EUNACOM 1.08.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Espondilitis Anquilosante (EA)**, también conocida como espondiloartritis anquilosante, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente al esqueleto axial (columna vertebral y articulaciones sacroilíacas). Es el prototipo de las espondiloartropatías seronegativas (factor reumatoide negativo).

Epidemiología y Perfil del Paciente

La EA tiene una presentación clínica muy característica que permite diferenciarla de otros tipos de dolor lumbar:

- **Sexo:** Es significativamente más frecuente en **hombres** que en mujeres.
- **Edad:** Suele comenzar en la **adolescencia o adultez joven**, casi siempre antes de los **40 años**.
- **Curso:** Es una enfermedad de inicio lento e insidioso que progresa a lo largo de los años.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Un lumbago que inicia después de los 45-50 años difícilmente será una Espondilitis Anquilosante; en esos casos se debe sospechar patología degenerativa o neoplásica.

Clínica: El Lumbago Inflamatorio

El síntoma cardinal es el **lumbago de características inflamatorias**. Es fundamental distinguirlo del lumbago mecánico (causado por hernias o sobreesfuerzo).

TABLA 14.30.1: CARACTERÍSTICA VS LUMBAGO INFLAMATORIO (EA)

CARACTERÍSTICA	LUMBAGO INFLAMATORIO (EA)	LUMBAGO MECÁNICO
Inicio	Insidioso (meses)	Agudo (días)
Reposo	Empeora el dolor	Mejora el dolor
Ejercicio	Mejora el dolor y la rigidez	Empeora el dolor
Rigidez matinal	Prolongada (>30-60 min)	Breve o ausente
Dolor nocturno	Frecuente (despierta al paciente)	Infrecuente

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Prueba terapéutica con AINES: Una característica muy sugerente de EA es la excelente respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. Si un paciente joven con lumbago crónico mejora drásticamente tras 48 horas de ibuprofeno o diclofenaco, la sospecha de EA aumenta significativamente.

Manifestaciones Extra-axiales

Aunque el compromiso de la columna es lo principal, la EA es una enfermedad sistémica:

- **Artritis Periférica:** Se presenta habitualmente como una **oligoartritis asimétrica**, que afecta principalmente a grandes articulaciones de las extremidades inferiores (caderas, rodillas).
- **Entesitis:** Inflamación en los sitios de inserción de tendones y ligamentos al hueso. El ejemplo más común es la **fasciitis plantar** o la tendinitis aquiliana.
- **Manifestaciones Extra-articulares:**
 - **Uveítis Anterior Aguda:** Es la manifestación extra-articular más frecuente (ojo rojo doloroso con fotofobia).
 - **Eritema Nodoso** y Pioderma Gangrenoso (menos frecuentes, pero asociados a espondiloartropatías).

- **Compromiso cardiovascular (aortitis) o pulmonar (fibrosis apical), aunque son raros.**

Exploración Física y Progresión

Con el tiempo, la inflamación crónica conduce a la **anquilosis** (fusión ósea) de la columna, lo que genera una pérdida severa de la movilidad.

- **Test de Schober:** Se utiliza para objetivar la limitación de la flexión de la columna lumbar. Se marca un punto a nivel de L5 y otro 10 cm más arriba; al agacharse, la distancia debería aumentar a más de 15 cm. En la EA, esta expansión está reducida.
- **Pérdida de la lordosis lumbar** y aumento de la cifosis dorsal (posición del "esquiador" en etapas avanzadas).

Diagnóstico e Imágenes

El diagnóstico se basa en la combinación de criterios clínicos y hallazgos imagenológicos.

1. Radiografía de Pelvis (Sacroilíacas)

Es el **primer examen** a solicitar. Se buscan signos de **sacroileitis**: - Borramiento del espacio articular. - Esclerosis subcondral. - Erosiones óseas. - Fusión (anquilosis) de la articulación.

2. Resonancia Magnética (RM)

Se solicita cuando la sospecha clínica es alta pero la radiografía es normal. - Es capaz de detectar la **sacroileitis activa** (edema óseo) mucho antes de que aparezcan los cambios estructurales en la radiografía. - Permite diagnosticar la **Espondiloartritis Axial No Radiográfica**.

3. Radiografía de Columna

En etapas avanzadas se observa la imagen patognomónica en **"Caña de Bambú"**: - Formación de **sindesmofitos** (puentes óseos entre las vértebras). - Calcificación de los ligamentos intervertebrales y del disco.

NOTA CLÍNICA

La anquilosis es el resultado final de un proceso de reparación ósea aberrante tras la inflamación de las entesis discales. El hueso nuevo reemplaza las estructuras elásticas, dejando la columna rígida y susceptible a fracturas.

4. Laboratorio y HLA-B27

- **HLA-B27:** Está presente en más del 90% de los pacientes con EA. Es un gran apoyo diagnóstico (alta sensibilidad), pero **no es específico**, ya que hasta un 8-10% de la población general sana es portadora del gen sin desarrollar la enfermedad. - **Parámetros inflamatorios:** La VHS y la Proteína C Reactiva (PCR) pueden estar elevadas, pero su normalidad no descarta la enfermedad.

Tratamiento

El objetivo es aliviar el dolor, mantener la movilidad y prevenir la deformidad.

- **AINES (Primera Línea):** Son el pilar del tratamiento. Se usan de forma continua o a demanda (ej. Indometacina, Naproxeno, Celecoxib, Etoricoxib). Mejoran los síntomas y podrían frenar la progresión radiográfica.
- **Ejercicio y Kinesiterapia:** Es fundamental realizar ejercicios de estiramiento y extensión de la columna diariamente para evitar que esta se "fije" en posiciones viciosas (anquilosis).
- **Terapia Biológica (Segunda Línea):** Si el paciente no responde a al menos dos AINES diferentes en dosis máximas durante 4 semanas, se utilizan:

- **Inhibidores del TNF-alfa** (Etanercept, Adalimumab, Infliximab).
- * Inhibidores de la IL-17 (Secukinumab).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

A diferencia de la **Artritis Reumatoide**, en la Espondilitis Anquilosante los fármacos modificadores de la enfermedad clásicos (como el Metotrexato) **no son útiles** para el compromiso de la columna (axial), aunque pueden servir para el compromiso periférico (artritis de rodilla o tobillo).

Resumen para el EUNACOM

- **Paciente tipo:** Hombre joven (<40 años) con dolor lumbar crónico.
- **Clínica clave:** Dolor que mejora con el movimiento y empeora con el reposo; rigidez matinal.
- **Asociaciones:** **Uveítis**, HLA-B27, sacroileitis.
- **Imagen:** Sacroileitis en radiografía o RM; "caña de bambú" en etapas tardías.
- **Tratamiento inicial:** AINES y ejercicios de columna.
- **Derivación:** Todo paciente con sospecha debe ser derivado a Reumatología para confirmar diagnóstico e iniciar terapia biológica si es necesario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 25 años con lumbago que empeora con el reposo y mejora con el ejercicio. Responde muy bien a ibuprofeno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Espondiloartritis Anquilosante. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Más frecuente en hombres jóvenes (antes de 40 años); lumbago inflamatorio que mejora con AINES
- Prueba terapéutica con AINES: buena respuesta apoya el diagnóstico
- Evoluciona a anquilosis de la columna (test de Schober para objetivar)
- Radiografía es primer examen; resonancia magnética si es normal y hay sospecha
- HLA-B27: sensible pero no específico (5-10% de la población lo tiene)
- Tratamiento: AINES + ejercicios; segunda línea: biológicos (anti-TNF-alfa)
- Signo de caña de bambú: imagen avanzada de anquilosis completa de columna

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESPONDILIOARTRITIS ANQUILOSANTE)**PREGUNTA 1**

Hombre de 25 años con lumbago que empeora con el reposo y mejora con el ejercicio. Responde muy bien a ibuprofeno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Hernia del núcleo pulposo
- B)** Lumbago mecánico
- C)** Espondilitis anquilosante
- D)** Fibromialgia
- E)** Fractura vertebral

PREGUNTA 2

Paciente con sospecha de espondilitis anquilosante tiene radiografía de sacroilíacas normal. ¿Cuál es el siguiente paso?

- A)** Descartar el diagnóstico
- B)** Solicitar TAC de columna
- C)** Solicitar resonancia magnética de sacroilíacas
- D)** Repetir la radiografía en 1 año
- E)** Solicitar densitometría ósea

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de segunda línea en espondilitis anquilosante que no responde a AINES?

- A)** Metotrexato
- B)** Corticoides orales
- C)** Inhibidores del TNF-alfa (biológicos)
- D)** Ciclofosfamida
- E)** Hidroxicloroquina

RESUMEN: ESPONDILOARTRITIS ANQUILOSANTE

La espondilitis anquilosante (EA) es más frecuente en hombres jóvenes (antes de los 40 años). Se caracteriza por lumbago inflamatorio (aumenta con reposo, disminuye con ejercicio) que responde muy bien a AINEs (prueba terapéutica con AINEs apoya el diagnóstico). Puede tener artritis periférica (oligoartritis asimétrica) y manifestaciones extraarticulares (uveítis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, dactilitis, entesitis). La evolución es lenta e insidiosa, progresando hacia anquilosis de la columna, objetivable con el test de Schober. El diagnóstico se hace con clínica más imágenes: la radiografía es el primer examen (signos de sacroileítis confirman), pero si es normal se pide resonancia magnética. La espondilitis no radiográfica tiene radiografía normal pero clínica compatible. El HLA-B27 es de apoyo diagnóstico (sensible pero no específico, 5-10% de la población lo tiene). El tratamiento es con AINEs (ibuprofeno, indometacina, celecoxib) más ejercicios de estiramiento. Si no responde, segunda línea son fármacos biológicos (inhibidores de TNF-alfa). La imagen avanzada muestra el signo de caña de bambú.